出血性疾病概述

分类

- 血管壁异常：过敏性紫癜（四肢对称分布，2008）—— 血管检测（2024）—— 出血时间 BT、束臂 / 毛细血管脆性试验 CRT、内皮素 ET；凝血酶 / 血栓调节蛋白 TM、血管性血友病因子 vWF“BF etc”
- 血小板数量减少：再障和白血病（生成减少）、ITP（破坏过多）、DIC（消耗过度）、脾亢（分布异常）
- 血小板质量异常：血小板无力症（缺乏 GPIIb/IIIa）、巨大血小板综合征（缺乏 GPIb）、尿毒症、感染
- 凝血异常：血友病、肝硬化、尿毒症、维生素 K 缺乏 —— 凝血检测（2014、2015、2016、2017、2023、2026）——
  - ①共有途径异常（10、5、2、1）：APTT、PT、TT（1）延长
  - ②内源性途径异常（8、9、11、12）：APTT 延长（凝血活酶生成障碍），PT 正常
  - ③外源性途径异常（7）：PT 延长，APTT 正常
- 抗凝及纤溶异常
  - 抗凝检测（2025）—— AT、TAT（凝血酶 - 抗凝血酶复合物）、PC、PS、TM、F Ⅷ抗体、狼疮抗凝物、心磷脂抗体
  - 纤溶检测（2019）—— 3P 试验、FDP、D- 二聚体、纤溶酶原、t-PA（激活物）、PAI（抑制物）、PIC（复合物）“二弟放 3 个 P”
- 复合性止血机制异常：DIC、血管性血友病（缺乏 vWF）

表现		
血管性疾病	血小板性疾病	凝血障碍性疾病“机关枪”（2013、2014、2016）
女性多见		男性多见、与遗传密切
紫癜多见	紫癜和瘀斑、眼底出血、月经过多、内脏出血多见	手术或外伤后渗血不止、脐带出血、肌肉血肿、关节出血、内脏出血多见

止血药

- 收缩血管、增加毛细血管致密度、改善通透性：维生素 C、糖皮质激素、曲克芦丁、卡巴克络、垂体后叶素“C 级丁克锁喉”
- 合成凝血相关成分所需：维生素 K
- 抗纤溶：氨基己酸、氨甲苯酸“蒜蓉”（2012）
- 促进止血因子释放：去氨加压素“学友释放假牙”